

## **Nota Orientativa Conjunta Nº25/2026 - Versão 2.1 - DMC/DTE/DVS/DGE/DAP**

**Assunto:** Orientações para os Serviços de Saúde sobre o fluxo de acesso do Implante Subdérmico de Etonogestrel (Implanon®) no Município de Joinville.

Conforme a Nota Técnica Conjunta Nº 419/2025-DGCI/DESCO/SAPS/MS que disponibiliza o Implante Subdérmico Contraceptivo liberador de etonogestrel 68mg às mulheres de 14 a 49 anos, com oferta prioritária na Atenção Primária à Saúde, bem como a legalidade, segurança jurídica e respaldo técnico da atuação de médicos(as) e enfermeiros(as) devidamente habilitados(as) na inserção e retirada de LARCs (Long Acting Reversible Contraceptives) - do Dispositivo Intrauterino (DIU) e do Implante Subdérmico Contraceptivo.

A incorporação do implante contraceptivo intradérmico no SUS foi oficializada pelas Portarias SECTICS/MS nº 47 e nº 48, ambas de 8 de julho de 2025: a primeira amplia seu acesso para mulheres adultas na faixa etária de 18 a 49 anos, enquanto a segunda incorpora o método especificamente para adolescentes de 14 a 17 anos, ampliando assim a cobertura para toda a população feminina em idade reprodutiva, de 14 a 49 anos, e reforçando o compromisso com a equidade no cuidado reprodutivo.

O implante contraceptivo intradérmico contém o hormônio etonogestrel e é colocado debaixo da pele do braço não dominante. Sua ação é contínua por 03 (três) anos e acontece com a liberação do hormônio para o sangue da mulher, funcionando por meio de 02 (dois) modos: impede a ovulação e espessa o muco do colo do útero, o que dificulta a passagem dos espermatozóides para o útero. Tem uma eficácia superior a 99%, igual ou superior a eficácia da laqueadura tubária (5 gravidezes em 10.000 mulheres que usam o implante).

A Secretaria da Saúde, por meio do Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos, publica o fluxo com as orientações para os serviços de saúde sobre o fluxo de acesso do Implante Subdérmico de Etonogestrel (Implanon®) no Município de Joinville.

Dessa forma, esta nota orientativa tem como finalidade orientar os serviços de saúde do município, garantindo padronização mínima das condutas, segurança assistencial e continuidade do cuidado.

A oferta do método ocorrerá de forma escalonada, com acesso mediante regulação assistencial, tratando-se de fase transitória, estando prevista posterior ampliação da oferta para a Atenção Primária à Saúde (APS), visando abranger o público feminino geral e consolidar o implante como opção acessível de contracepção de longa duração em toda a rede.

## **1 ACESSO AO IMPLANTE SUBCUTÂNEO DE ETNOGESTREL NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC**

Deve ser realizada uma avaliação clínica criteriosa considerando os demais métodos disponíveis na rede de atenção à saúde.

O encaminhamento para a realização do implante subcutâneo de etonogestrel deve ser realizado a partir de uma consulta de planejamento familiar, na atenção primária ou serviço especializado no âmbito do SUS do município. O profissional deve avaliar as indicações.

### **1.1 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO**

Público-alvo: Mulheres em idade fértil (14 a 49 anos).

#### **1.1.1 Grupos Prioritários (Vulnerabilidade)**

A prioridade deve ser dada a mulheres que apresentem uma ou mais das seguintes condições:

- Vulnerabilidade social, insegurança alimentar grave, residentes em áreas de alto risco ou conflitos armados, situação de rua, cadastradas no Centro POP ou CadÚnico;
- Vítimas de violência;
- Se puerpera de alto risco na última gestação;

- Vivendo com HIV ou Transtornos mentais que causem vulnerabilidade psicossocial, incluindo condições cognitivas;
- Comportamentais e neurológicas que comprometam o autocuidado, a compreensão e a interação social adequada;
- Em tratamento com medicamentos que possam causar complicações na gestação, conforme avaliação e indicação técnica da equipe responsável pelo serviço, como talidomida, dolutegravir e aminoglicosídeos;
- Pessoas privadas de liberdade;
- Profissionais do sexo.

## **2 REQUISITOS CLÍNICOS GERAIS PARA O IMPLANTE SUBCUTÂNEO DE ETONOGESTREL**

- **Consentimento Informado:** aceitação e consentimento livre e informado da paciente, após aconselhamento completo sobre opções, eficácia, efeitos colaterais e duração;
- **Ausência de contraindicações:** não apresentar contraindicações conforme critérios médicos de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde - OMS, categoria 1 ou 2;
- **Confirmação de Não Gravidez:** resultado negativo para teste de gravidez no momento da inserção.

## **3 CONTRAINDICAÇÕES**

As contraindicações para o uso do implante contraceptivo subdérmico de etonogestrel baseiam-se principalmente nos Critérios de Elegibilidade Médica para Uso de Contraceptivos da Organização Mundial da Saúde (OMS), que são adotados como referência pelo Ministério da Saúde.

Para consulta da tabela completa das categorias 1,2,3 e 4 da OMS - acessar os [Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso Métodos Anticoncepcionais](#).

#### **4 INDICAÇÃO E PRESCRIÇÃO**

A indicação e a prescrição do implante subdérmico de etonogestrel devem ser realizadas por médico(a) ou enfermeiro(a).

O profissional deve:

- Realizar avaliação clínica completa; durante a consulta médica ou de enfermagem com ênfase no planejamento sexual e reprodutivo;
- Verificar o enquadramento da usuária nos critérios de elegibilidade (categorias 1, 2, 3 e 4 da Organização Mundial da Saúde - OMS);
- Registrar detalhadamente no prontuário a indicação, contendo a descrição completa do caso, os critérios avaliados e as orientações prestadas;
- O profissional médico(a) ou enfermeiro(a) deve fazer o encaminhamento via sistema SIG-Saúde Tech (Código 03.01.04.017-6 - inserção do implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel) e orientar a usuária sobre o fluxo de inserção do implante (Anexo B).

#### **5 INSERÇÃO DO IMPLANTE**

A inserção do dispositivo anticoncepcional subdérmico será executada exclusivamente por profissionais de saúde que tenham passado por capacitação prévia e específica para o procedimento.

Tempo estimado para cada atendimento: 30 a 40 minutos.

O local de realização do procedimento será definido conforme a origem do encaminhamento e a disponibilidade de vagas na rede de saúde. Para as usuárias encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), o procedimento

será agendado preferencialmente em UBSF com profissional habilitado. Já as pacientes referenciadas pela Atenção Especializada terão como local preferencial a Clínica Especializada em Saúde da Mulher. Ressalta-se que a Clínica Especializada também poderá absorver a demanda de usuárias vindas das UBSFs, atuando como suporte de acordo com a disponibilidade de suas vagas.

O fluxo de encaminhamento originado nas UBSFs será monitorado e regulado pelo médico da coordenação da Estratégia Saúde da Família (ESF). Este profissional será responsável por avaliar os critérios normativos, mapear quais unidades contam com profissionais habilitados no momento e efetuar o agendamento conforme a disponibilidade de vagas do sistema. Por fim, a comunicação e o aviso sobre a data e o horário agendados para o procedimento segue responsabilidades institucionais distintas: para os casos marcados nas UBSFs, o aviso à usuária fica sob responsabilidade da própria unidade de origem; já para os atendimentos agendados na Policlínica/Clínica Especializada em Saúde da Mulher, cabe a equipe de regulação realizar o contato com a usuária.

Nos casos específicos de usuárias cuja indicação e prescrição tenham sido realizadas pelas equipes do Consultório na Rua ou da Unidade de Saúde Prisional, o procedimento de inserção será executado no próprio local pelo profissional capacitado da respectiva equipe.

## **5 ORIENTAÇÕES E CUIDADOS PÓS INSERÇÃO**

O profissional responsável pela inserção deve orientar a pessoa sobre os cuidados imediatos após o procedimento, os sinais de alerta e os cuidados a serem observados durante o uso do implante. As principais orientações, seguem descritas abaixo.

**Cuidados com o curativo:** manter o curativo fechado, seco e limpo por 24 horas, removendo-o no dia seguinte. Recomenda-se utilizar uma cobertura adesiva transpirável (ex.: micropore) sobre o orifício de entrada por uma semana.

**Prática Sexual Protegida:** caso a inserção ocorra após o 7º dia do ciclo menstrual, recomendar o uso de método de barreira (preservativo) por 7 dias consecutivos, mesmo com teste de gravidez negativo.

**Prevenção de ISTs:** reforçar o uso de preservativo nas relações sexuais para proteção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), esclarecendo que o implante previne apenas a gravidez indesejada.

**Retorno imediato (em até 7 dias):** procurar imediatamente o local onde foi realizado o procedimento caso apresente sinais de alarme: dor intensa; hematoma grande; sinais de infecção (vermelhidão, calor, inchaço, pus ou febre); suspeita de expulsão do dispositivo.

Após, deve ser referenciado à Unidade de Saúde responsável pela inserção nas seguintes situações:

- Sangramento uterino intenso ou muito prolongado que cause anemia ou interfira gravemente na vida da mulher;
- Dor abdominal intensa ou dor no local do implante que não melhora com medidas simples;
- Implante não palpável (não consegue sentir no braço);
- Suspeita de expulsão ou quebra do implante;
- Sinais de infecção no braço (vermelhidão forte, inchaço, pus, febre);
- Desejo de retirada do implante (por qualquer motivo: querer engravidar, trocar de método ou intolerância);
- Suspeita de gravidez com o implante colocado;
- Qualquer sinal ou sintoma de trombose (inchaço e dor forte em uma perna, falta de ar repentina, dor forte no peito).

## **6 REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO**

O implante subdérmico deve ser removido em situações em que houver problemas relacionados à inserção, estrutura do implante, complicações associadas ao

uso de etonogestrel ou a pedido da pessoa ou de seu responsável. A substituição é indicada quando o prazo de validade do implante (3 anos) é atingido ou em situações técnicas específicas, como em pessoas com sobrepeso ou obesidade, ou em casos de exposição ou deslocamento do dispositivo.

**Nota:** no Sistema SIG-Saúde Tech, utilizar o código 03.01.04.018-4 – retirada do implante subdérmico liberador de etonogestrel, para encaminhamento de remoção do implante.

## ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO (VERSÃO 2025 PARA 2026)

**Quadro 01.** Alterações das versão 1 da Nota Orientativa Conjunta N°25/2025 para a versão 2 N°25/2026

| Área/tema                                     | Versão 1<br>N°25/2025                                                 | Versão 2<br>N°25/2026                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inserção do Implante</b>                   | Realizado exclusivamente na Clínica Especializada em Saúde da Mulher. | Incluído as Unidades Básicas de Saúde (UBSFs) com profissionais capacitados, o Consultório na Rua e a Unidade de Saúde Prisional |
| <b>Tempo estimado e materiais necessários</b> | Não mencionava estes dados.                                           | Inclusão do tempo estimado de procedimento e da lista de materiais necessários.                                                  |
| <b>Remoção do Implante</b>                    | Não informa o código no Sistema SIG-Saúde para remoção do implante.   | Informa o código específico no Sistema SIG-Saúde Tech para remoção do implante                                                   |

**Elaborado por:** Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos (NGQ), 2026.

## REFERÊNCIAS

ANVISA. **Detalhe do Produto: Implanon**. Brasília, DF: ANVISA, 2024. Disponível em: <<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2841418?numeroProcesso=25351362071202187L>>. Acesso em: 27 nov. 2025.

ESPEY, E.; OGBURN, T. Long-Acting Reversible Contraceptives: Intrauterine Devices and the Contraceptive Implant. **Obstetrics & Gynecology**, [s. l.], v. 117, n. 3, p. 705-713, 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21343774/>. Acesso em: 12 nov. 2025.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. **Contracepção Reversível de Longa Ação**. São Paulo: FEBRASGO, 2022. (Série Orientações e Recomendações, n. 1). Disponível em: <https://www.febRASGO.org.br/media/k2/attachments/SerieZ1-2022-Contracepcao.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2025.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. **Diretrizes Brasileiras de Contracepção (2021–2023)**. São Paulo: FEBRASGO, [2023].

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Critérios médicos de elegibilidade para o uso de métodos anticoncepcionais**. 5. ed. Genebra: OMS, 2015. Apêndice D: Tradução para o português. Disponível em: <https://saudedireta.com.br/docsupload/1340375131Portuguese-AppendixD.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Medical eligibility criteria for contraceptive use**. 5. ed. Geneva: World Health Organization, 2015. ISBN 978-92-4-154915-8. Disponível em: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/1a86af83-37b7-4fbc-8936-d1a1ed6ae30c/content>. Acesso em: 9 jun. 2026. [1, 2]

SCHERING-PLOUGH. **Bula profissional: Implanon - Etonogestrel - Implante 68 mg**. Implanon Bula Prof Saúde RDC 47. [S. l.]: Schering-Plough, out. 2010.

**Anexo A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a inserção do implante subdérmico de etonogestrel 68mg.**

Eu, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ anos, CPF \_\_\_\_\_, venho por meio deste TERMO, autorizar a inserção de implante subdérmico de etonogestrel 68 mg, e que me foi explicado acerca dos riscos, benefícios e cuidados, e estou ciente de que o método previne exclusivamente gravidez indesejada, e que para proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, devo utilizar método de proteção de barreira, como preservativo.

Declaro que:

1. Fui informada que o implante de etonogestrel 68 mg é um método contraceptivo seguro, reversível, eficaz e indicado para pacientes que desejam contracepção de longa duração e que não apresentam contraindicações ao seu uso, e que posso solicitar sua remoção a qualquer momento;
2. Declaro que forneci ao profissional de saúde informações completas, verdadeiras e atualizadas sobre meu estado de saúde, histórico médico, doenças atuais ou passadas, alergias, medicamentos em uso, cirurgias anteriores, gravidez atual ou suspeita, trombozes, câncer, problemas hepáticos graves ou qualquer outra condição que pudesse representar uma contraindicação ao uso do implante. Entendo que a segurança do método depende dessas informações corretas.
3. Foi esclarecido que independente do dia do ciclo menstrual, será necessário realizar um teste rápido para detecção de gravidez no dia da inserção, e não poderei realizar o procedimento caso o resultado seja positivo;
4. Após esclarecimento de todas as dúvidas, escolhi o método implante de etonogestrel 68 mg, o qual será inserido gratuitamente por profissional capacitado;
5. Comprometo-me a realizar os seguintes cuidados pós inserção:
  - a. Curativo fechado por 24h;
  - b. Não molhar o curativo;
  - c. Não realizar esforços com o braço que foi inserido o implante, ou deitar-se sobre o mesmo nas primeiras 48 horas;
6. Fui plenamente esclarecida sobre os riscos e efeitos colaterais, e escolhi de minha livre e espontânea vontade a sua inserção, após ter compreendido todas as orientações fornecidas.
7. Em caso de incapacidade, assina este documento, o representante legal do paciente abaixo descrito:

NOME COMPLETO \_\_\_\_\_

PARENTESCO: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Profissional responsável pela orientação do Termo: \_\_\_\_\_

Categoria profissional: \_\_\_\_\_

Registro no Conselho de Classe: \_\_\_\_\_

Joinville, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

Assinatura da solicitante ou responsável legal \_\_\_\_\_

Assinatura do profissional \_\_\_\_\_

- ( ) Inserção do Implante de Etonogestrel 68mg  
( ) Troca do Implante de Etonogestrel 68mg

**Anexo B.** Fluxo de Inserção do Implante Subdérmico de Etonogestrel nas usuárias encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) e Atenção Especializada.

